

· 艾滋病研究 ·

栏目主编: 王健, 徐立然 协办: 中华中医药学会防治艾滋病分会 国家中医药治疗艾滋病临床研究基地

中医外治法治疗艾滋病相关腹泻 Meta 分析^{*}

侯明杰¹, 郭娇², 原海珍¹, 王延丽¹, 陈媛媛¹, 刘旭辉¹, 赵清霞¹

1. 郑州市第六人民医院, 河南 郑州 450061; 2. 河南中医药大学第一附属医院, 河南 郑州 450000

摘要: 目的: 观察中医外治法治疗艾滋病相关腹泻(HIV/AIDS related diarrhea, HRD) 的有效性及安全性。方法: 计算机检索 CNKI、PubMed、万方和 VIP 数据库, 查阅所有中医外治法治疗 HRD 的随机对照试验(randomized controlled trial, RCT), 自建库至 2016 年 6 月 30 日发表的文献均纳入检索范围。并对纳入文献的参考文献进行手工检索。按纳入标准、排除标准由两人独立进行 RCT 的筛选、资料提取和质量评价后, 采用 RevMan 5.3 软件进行 Meta 分析。结果: 共纳入 4 个研究, 394 例患者。Meta 分析结果显示: 中医外治法和常规治疗相比, 疗效指标差异有统计学意义($P < 0.05$)。证据的质量和推荐的等级结果显示: RCT 证据的水平均为低级; 其推荐强度均为弱推荐。结论: 中医外治法与常规治疗相比, 疗效更确切, 安全性更高。但因原始研究中 RCT 较少, 质量普遍较低, 建议结合临床具体情况使用, 同时进一步采用更多大样本、高质量的 RCT 进行论证。

文献引用: 侯明杰, 郭娇, 原海珍, 等. 中医外治法治疗艾滋病相关腹泻 Meta 分析 [J]. 中医学报, 2017, 32(12): 2275 - 2279.

关键词: 艾滋病相关腹泻; 中医外治法; Meta 分析

DOI: 10.16368/j.issn.1674-8999.2017.12.593

中图分类号: R259.129.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-8999(2017)12-2275-05

TCM External Therapy in AIDS Related Diarrhea of Meta Analysis

HOU Mingjie¹, GUO Jiao², YUAN Haizhen¹, WANG Yanli¹, CHEN Yuanyuan¹, LIU Xuhui¹, ZHAO Qingxia¹

1. The Sixth People's Hospital of Zhengzhou, Zhengzhou Henan China 450061; 2. The First Affiliated Hospital of Henan University of Chinese Medicine, Zhengzhou Henan China 450000

Abstract: Objective: To explore the effectiveness and safety of external therapy of TCM treatment of HIV/AIDS related diarrhea. Methods: Such databases as Pubmed, VIP, CNKI and Wanfang were searched from their establishment to 30 June 2016 for collecting the randomized controlled trials(RCTs) about external treatment of TCM of AIDS related diarrhea, and the references of those RCTs were also searched by hand. After study selection, assessment and data extraction conducted by two reviewers independently, meta-analyses were performed by using the RevMan 5.3 software. Results: Four studies involving 394 patients were included. The results of meta-analyses showed that: external treatment of TCM compared with conventional therapy, the curative effect difference was statistically significant($P < 0.05$). Quality of evidence and recommended grade results showed that: The level of RCT evidence was low; the recommended strength was weak recommendation. Conclusion: The safety of external treatment of TCM is higher, the curative effect is better; However, because of the less RCT and lower quality in the original study, it is suggested that it be used in combination with specific clinical conditions. We still need to further use more large samples, high-quality RCT to demonstrate.

Reference citation: HOU Mingjie, GUO Jiao, YUAN Haizhen, et al. TCM External Therapy in AIDS Related Diarrhea of Meta A-

^{*} 基金项目: “十三五”艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治科技重大专项(2017ZX10202101-001-010); 河南省医学科技攻关项目(201702327); 河南省郑州市科技攻关项目(141PPTGG318)

analysis [J]. Acta Chinese Medicine, 2017, 32(12): 2275-2279.

Key words: HIV/AIDS related diarrhea; external treatment of TCM; Meta analysis

艾滋病(acquired immune deficiency syndrome, AIDS)是一种获得性免疫功能缺陷综合征,是由人类感染艾滋病病毒(human immunodeficiency virus, HIV)所引起的一种恶性传染病,具有很强的传染性和极高的病死率^[1]。腹泻是 HIV/AIDS 常见的一种症状和机会性感染,长期的腹泻会逐渐引起消瘦、营养不良甚至恶液质,是引起艾滋病患者死亡的主要原因之一,其发生率为 30%~80%,特别是在发展中国家和热带地区的艾滋病患者,腹泻的发生率高达 90%^[2]。高效抗逆转录病毒治疗(highly active antiretroviral therapy, HAART)能够有效地抑制 HIV 病毒,重建免疫功能,使艾滋病相关腹泻(HIV/AIDS related diarrhea, HRD)的发生率下降到 13%^[3],但在临床上 HRD 仍非常多见,HRD 在 HAART 治疗后有了新的临床特点;HAART 药物特别是含 LPV/r 的药物组合导致腹泻值得重视,研究显示腹泻发生率为 16%~28%。张晓伟等^[4]发现,AIDS 相关腹泻中,HAART 药物相关性腹泻的比例高达 65.60%。HRD 的病因复杂,表现多样,多为慢性腹泻,病程长,治疗困难,且易复发,现代医药的抗病原体治疗和对症治疗效果欠佳,中医辨证论治特别是外治法,在 HRD 的治疗上有一定的优势,并且积累了一定的临床经验^[5]。本文拟通过对已公开发表的中医辨证外治法治疗艾滋病相关腹泻的疗效评价的文章进行荟萃分析,以进一步评价其疗效。

1 资料与方法

1.1 检索策略 由 2 名评价员(侯明杰、郭娇)分别独立检索 PubMed、VIP、CNKI 和万方数据库中公开发表的中/英文中医外治法治疗 HIV/AIDS 相关性腹泻的随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)文献。自建库至 2016 年 6 月 30 日发表的文献均纳入检索范围。同时对纳入文献的参考文献进行手工检索。同时,为尽可能增加纳入文献资料,完善研究内容,如待纳入文献中试验相关资料不完善,通过邮件、电话等与原作者联系获取。

1.2 文献纳入标准

1.2.1 研究类型 纳入所有中医辨证外治法治疗艾滋病相关腹泻的 RCT,不管是否采用了盲法。

1.2.2 研究对象 纳入经临床诊断为 HRD 并采用中医外治法治疗的患者。排除明确诊断为痢疾、霍乱、中毒、寄生虫感染、恶性肿瘤,以及全身性疾病引起的腹泻。排除合并心脑血管、肝、肾、内分泌和造血系统严重原发性疾病者。排除妊娠或哺乳期妇

女。排除过敏体质或中医外治过敏者。排除精神异常者。排除已接受其他相关治疗,并可能对本研究的观测指标有影响者。种族和国籍不限。

1.2.3 干预措施 试验组采用单纯中医外治(包括穴位注射、艾灸、针灸等)或在中医外治基础上联合其他常规治疗,对照组采用常规治疗。

1.2.4 测量指标 一般生命体征如:体温、呼吸、脉搏、血压;常规生化检验结果如:血常规、尿常规、粪常规、肝功能、肾功能;以及心电图。有效性指标:临床症状等级,采用计分方法统计。见表 1。

表 1 临床症状分级量化表

症状		轻	中	重
主症	腹泻次数	3 次·d ⁻¹ (2 分)	4~5 次·d ⁻¹ (4 分)	每日 6 次以上(6 分)
	大便性状	大便不成形(2 分)	大便稀溏(4 分)	大便溏薄(6 分)
次症	体倦乏力	积本力劳动(1 分)	勉强日常活动(2 分)	不能日常活动(3 分)
	脘腹闷胀	偶有发生(1 分)	天天有发生(2 分)	持续存在(3 分)
	食欲不振	食量减少 1/3(1 分)	食量减少 1/2(2 分)	食量减少 2/3(3 分)
	神疲懒言	精神不振(1 分)	精神倦怠(2 分)	精神疲倦易睡(3 分)
	腹痛	偶有(1 分)	常有(2 分)	每天有持续(3 分)
舌脉	舌质	舌淡胖或有齿印		
	舌苔	苔薄白或苔白腻		
	脉象	细弱、濡脉、缓脉		

注:病情程度分级标准,轻度为 4~9 分,中度为 10~15 分,重度为 16 分以上。舌脉象不计分

1.3 文献排除标准 检索过程中仅检索到文献摘要,且联系作者未回复者。Mate 分析所需资料显示不全且联系作者未回复;或虽回复仍未获得必须资料者。若两篇文献报道来自同一机构,且发表在相似的随访区间或有相同的目标结果时,选择质量更好或信息更全面的报道纳入,并与作者联系澄清分歧。

1.4 文献质量评价

1.4.1 偏倚风险评估 评估标准参照《Cochrane 系统评价员手册 5.3 版》,由 2 名评价员(侯明杰、郭娇)对纳入的 RCT 独立进行偏倚风险评估,如果遇到分歧由第 3 位评价员(原海珍)参与讨论,最终达成意见统一。2 名评价员分别从随机分配方案的产生、分配方案的隐藏、盲法的实施、结果数据的完整性、无选择性报告结果、其他偏倚来源这 6 个方面对所纳入文献进行评价。其中,其他偏倚来源的评价中“Low risk”表示低偏倚风险,“High risk”表示高偏倚风险,“Unclear risk”表示文献对偏倚评估未提供足够的或不确定的信息。

1.4.2 证据质量及推荐等级 基于系统评价的结果,应用 GRADE 系统评价证据质量及推荐等级。证据质量分级如下:高质量(或 A):我们非常确信真实的效应值接近效应估计值。中等质量(或 B):对效应估计值我们有中等程度的信心:真实值有可能接近估计值,但仍存在两者大不相同的可能性。

低质量(或 C):我们对效应估计值的确信程度有限:真实值可能与估计值大不相同。极低质量(或 D):我们对效应估计值几乎没有信心:真实值很可能与估计值大不相同。

1.5 资料提取 由 2 位评价员(侯明杰、郭娇)分别独立进行,如果遇到分歧由第 3 位评价员(原海珍)参与讨论决定。内容包括纳入标准、样本量、抽样方法和过程分组方法和过程、研究对象的基本资料、研究的条件、干预的方法、测量的指标、随访持续的时间、病例流失率和流失的原因、统计学方法。缺失的资料联系作者索取。

1.6 统计学方法 采用 RevMan5.3 软件进行 Meta 分析。软件由 Cochrane 协作网提供。首先通过 χ^2 检验和 I^2 检验对同类研究进行异质性评价,若 $P \geq 0.1, I^2 \leq 50\%$,说明研究间存在异质性的可能性小,分析使用固定效应模型。若 $P < 0.1, I^2 > 50\%$,说明研究间的异质性明显,则需要对其异质性的来源进行分析,根据可能出现的异质性因素进行亚组分析(如亚组只有一项研究仍采用与 Meta 分析相同的统计量),必要时采用敏感性分析来分析检验结果的稳定性,若异质性过大并不能判断其来源则放弃 Meta 分析改为描述性分析。计数资料采用相对危险度(RR)作为分析统计量。对连续性资料,如使用测量工具相同,则采用加权均数差(MD)进行分析;若对相同变量使用不同测量工具,则采用标准化均数差(SMD)进行分析。所有分析均计算 95% 可信区间(CI)。若临床试验提供数据不足,只对其进行描述性分析。同时,采用漏斗图判断发表偏倚。

2 结果

2.1 纳入文献中患者一般情况及基线特征分析 根据检索式初检出相关文献 42 篇,其中英文 1 篇,中文 41 篇。经阅读文题和(或)摘要后剔除明显不符合纳入标准的 37 篇。然后查找阅读全文,进一步

剔除重复发表,排除研究目标相同的 1 篇后,最终纳入合格文献 4 篇^[6-9],共 394 例患者。将各文献中患者的一般资料及患病情况等资料进行统计学分析,差异无统计学意义($P > 0.05$)。

2.2 纳入研究的偏倚风险评价 根据 Cochrane 协作网推荐的偏倚风险评估方法对所纳入的研究进行评价,结果提示:纳入的 4 个研究基线具有可比性,但均有不同水平的偏倚(见图 1、图 2)。4 个研究均提及“随机”,其中 1 个研究描述为随机数字表产生^[8],其余未进行详细描述。所有研究均未报道盲法及分配方案隐藏情况。所有研究均完整报道了研究结果,均无选择性报道结果。

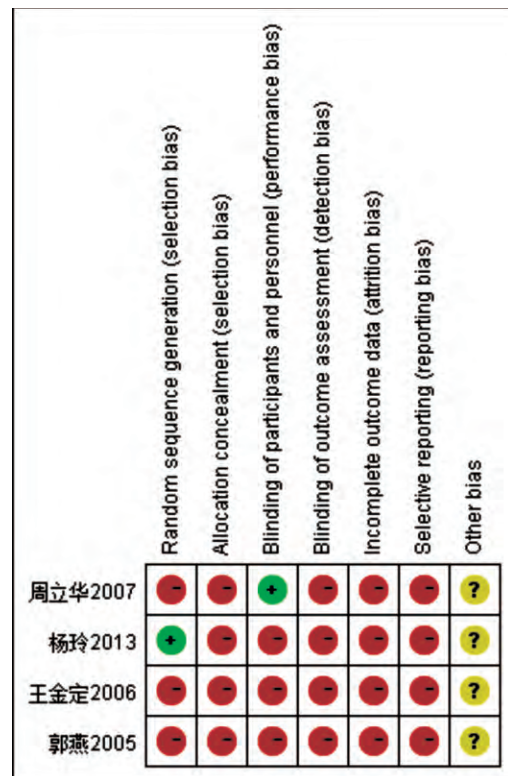


图 1 偏倚风险图:对纳入研究中每个偏倚风险项目的判断

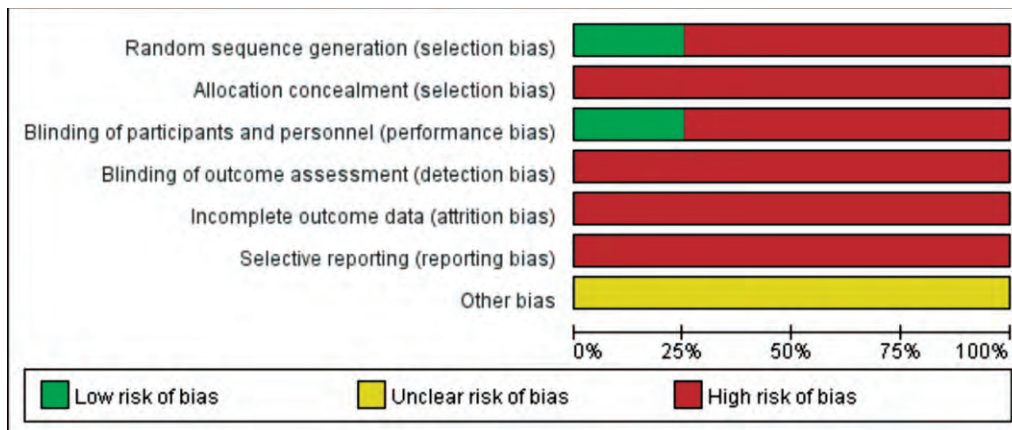


图 2 偏倚风险图:对纳入研究中产生偏倚风险的项目所占百分比的判断

2.3 Meta 分析结果 4 个研究比较了疗效,见图 3。4 个纳入研究间的异质性小($P = 0.71$, $I^2 = 0\%$),分析方法需应用固定效应模型。Meta 分析结果表明:中医外治法相对于现代医学疗法在治疗

HRD 方面,疗效是确切的。

2.4 发表偏倚 因研究数量有限,未能进行漏斗图分析。

Study or Subgroup	Experimental		Control		Weight	Odds Ratio M-H, Fixed, 95% CI
	Events	Total	Events	Total		
周立华 2007	83	88	23	34	21.3%	7.94 [2.50, 25.16]
杨玲 2013	38	41	32	41	26.5%	3.56 [0.89, 14.28]
王金定 2006	46	50	31	50	28.1%	7.05 [2.19, 22.72]
郭燕 2005	56	60	24	30	24.1%	3.50 [0.91, 13.53]
Total (95% CI)		239		155	100.0%	5.46 [2.92, 10.21]
Total events	223		110			
Heterogeneity: Chi ² = 1.37, df = 3 ($P = 0.71$); $I^2 = 0\%$						
Test for overall effect: Z = 5.31 ($P < 0.00001$)						

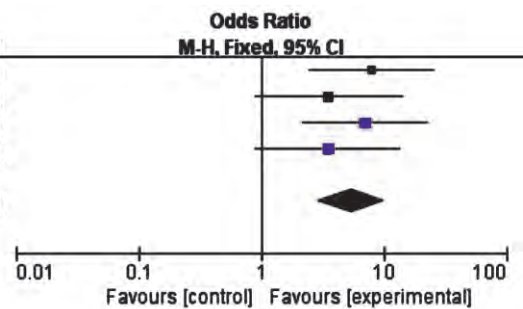


图 3 纳入研究的疗效森林图

3 讨论

3.1 安全性分析 研究过程中未观察到过敏现象、药物不良反应或不良事件以及严重不良反应或不良事件发生,说明本研究方法是安全的。

3.2 有效性分析 HRD 主要病变部位是肠道。周玉玲等^[4]研究发现,HRD 常见的病原体为真菌、抗酸杆菌、隐孢子虫。现代医学根据检出的不同病原体,给予抗生素类、抗原虫、抗病毒类、抗真菌以及保护胃肠道黏膜等治疗,可暂缓缓解症状,短期疗效尚可,但存在许多问题,如长期用药所导致的耐药,停药后复发,实施相应病原体检测条件复杂等。

中医辨证论治在治疗 HRD 方面取得了很好的疗效,运用中医辨证论治可以起到健脾渗湿、补益脾肾以扶正利湿驱邪的作用。中医外治法(穴位注射、艾灸、水针等)可以调节脏腑功能、改善体质、提高免疫、治疗机会性感染等,疗效明显。

中医辨证治疗泄泻起源于《黄帝内经》,由后世医家不断完善和补充。《黄帝内经》称为“濡泄”“飧泄”“洞泄”“鹜溏”“注下”“后泄”等。《素问·脏气法时论》云“因于露风,乃生寒热,是以春伤于风,邪气留恋,乃为洞泄。”《素问·举痛论》曰“寒气客于肠,小肠不得成聚,故后泄腹痛矣。”《素问·至真要大论》曰“诸呕吐酸,暴注下迫,皆属于热。”《素问·阴阳应象大论》云“湿盛则濡泄……春伤于风,夏生飧泄。”提出风、寒、湿、热皆可引起泄泻,并以长夏多发。《素问·脏气法时论》云“脾病者……虚则腹满胀鸣,飧泄食不化。”《素问·宣明五气》曰“大肠小肠为泄。”《素问·脉要精微论》曰“胃脉实则胀,虚则泄。”说明泄泻的病变脏腑与脾胃及肠道有关。《金匱要略·呕吐下利病脉证治》中记载的下利包含泄泻和痢疾,并指出湿热和虚寒为泄泻的主要病因。《景岳全书·泄泻》曰“肾为胃关,开窍于二阴,所以二便之开闭,皆肾脏之所主,今肾

中阳气不足……即令人洞泄不止。”HRD 属中医学“泄泻”范畴,其病因病机可概括为“邪之所凑,其气必虚”。疫毒入侵,正气亏虚,风、寒、湿、热入侵,日久脏腑虚衰,脾不能统摄,胃受纳失常;或暴饮暴食,饮食不节,损伤脾胃;情志失调,肝气乘脾;或湿盛困脾,致脾失健运,大肠失司,而致泄泻。疾病日久必气阴亏虚,若气机不畅,则命门火衰,不能温煦脾阳,脾阳不升,可导致长期泄泻,迁延不愈。病位主要在脾,若日久则伤及肾^[1]。

艾灸神阙、关元、足三里等穴位有回阳固脱、健脾温肾、散寒止泻之功效。《灵枢·经脉》曰“陷下则灸之。”《灵枢·禁服》云“陷下者,脉血结于中,中有著血,血寒,故宜灸之。”指虚寒之病证,脉陷下而不起者,为气虚血滞,宜用灸法温经散寒。《本草纲目》谓“艾叶苦辛,性温,纯阳之性。能回垂绝之阳,通十二经,走三阴,理气血,逐寒湿……以之灸火,能透诸经而除百病。”艾灸适用于 HIV/AIDS 免疫缺陷患者,研究发现其对免疫球蛋白中的 IgA、IgG 有一定影响,可提高机体的免疫力^[2]。

HRD 的证候特点及病因病机研究是辨证论治的理论基础。张晓伟等^[3]于 2013 年进行的一项研究发现,HRD 主要表现为慢性泄泻,证候以脾胃虚弱证和肾阳虚衰证多见。张昊^[4]通过文献研究、问卷调查及临床处方研究发现,艾滋病相关腹泻出现最多的证候为脾胃虚弱证和脾肾阳虚证。赵少英等^[5]于 2016 年通过文献研究、流行病学调查、病例回顾性分析整合了近年来艾滋病相关腹泻的中医常见证候特点,确立了艾滋病相关腹泻常见的 3 个证型:脾胃虚弱证、脾肾阳虚证、肠道湿热证。桑海艳等^[6]对河南地区 HRD 患者的临床资料进行证候要素分析和因子分析,结果显示病位主要在脾,与肾脏关系密切;HRD 的病因分为内因和外因:外因以湿邪为主,可兼热、气滞等,内因以气血亏虚、正虚劳损等为主;故 HRD 适合应用中医外治法特别是艾灸治

疗,以健脾温肾、散寒除湿,使脾胃功能恢复,受纳、运化正常,清气升,浊气降;温煦肾阳,寒气得散,水液化气、疏布正常,二阴开合正常,则泄止。但对于以肠道湿热为主证的泄泻不建议应用。

中医外治法治疗艾滋病相关腹泻的疗效报道逐渐增多,但高质量的随机对照试验较少。郭燕等^[4]对 65 例 HRD 患者辨证为:脾肾阳虚型、脾胃虚弱型和脾肺气虚型;随机分两组,治疗组应用艾条温和灸,对照组应用糖盐水补液,同时口服黄连素片,结果显示治疗组疗效明显优于对照组。王金定等^[5]将 100 例 HRD 患者随机分两组,常规组给予输液、抗病原体、纠正酸碱平衡紊乱及补充水电解质治疗;治疗组加用艾条灸疗法,结果显示治疗组有效率优于常规组。周立华等^[6]对 122 例 HRD 患者进行了临床观察,分别应用艾条温和灸、氟哌酸胶囊加蒙脱石散口服和参苓白术丸口服 3 种方法,艾灸组疗效优于西药组和中成药组。杨玲等^[7]将 82 例 HRD 患者采用数字随机表法分成两组,研究结果显示:藿朴夏苓汤联合山莨菪碱穴位注射组疗效优于氟哌酸胶囊口服组。以上研究表明,HRD 临床诊治中,联合中医外治法可提高疗效,缩短疗程。但仍然需要更多高质量、多中心和大样本的 RCT 进行深入研究。

3.3 GRADE 证据质量及推荐等级 GRADE 系统中,基于 RCT 得出的证据认为是高质量的,但对于目前发表的关于 HRD 的研究,我们有可能对该类证据的信心会降低。原因为:隐藏和盲法缺失;部分中医药研究纳入的多为主观指标,观察的客观指标较少,描述并不够精确;部分结果存在发表偏倚。另外,中医外治法的疗效评价是本研究主要的结局指标,称为“重要”的结局指标,本研究纳入的 4 篇原始研究文献的质量不高,对结局指标的真实性有一定影响。同时,研究的对象均为中国人,影响了结论的外推性,所以推荐级别为“弱推荐”。

3.4 研究的局限性 本评价仍存在一定的不足,以下方面有待于进一步完善:国内发表的部分临床研究证据等级偏低,本研究最终纳入的 4 篇合格文献,并不完全是标准的、高质量的 RCT。部分结局指标不可避免存在一些发表偏倚,检索策略尽管比较充分、广泛,但仍有些相关文献无法获取,如一些会议论文、增刊等,而且纳入研究的信息有限,本研究只能就 HRD 的症状评分、临床疗效等这些少量指标进行评价,且不能完全排除潜在的发表偏倚。中医外治法属于中国传统医学,本研究检索虽然未限制语种,但经检索后所纳入的文献 4 篇均为中文,没有英文(分析其原因:可能是由于中医外治法如灸法、穴位贴敷等均属于传统的中医疗法,国外虽有相关病例报道,但中医文化氛围、中医操作技术、接受程度等均不如国内),所

以可能影响研究结果的外推性。

4 结论

综上所述,当前证据表明,中医外治法与传统治疗方法相比,临床疗效确切,安全性高,尤其对于艾滋病相关慢性腹泻脾胃受损、脾肾阳虚,运化失常、湿浊内生者,临床医生可考虑在辨证施治的基础上联合中医外治法,有费用低、操作方便、基层可推广性强等优势。但因本研究所纳入的原始文献研究质量等级较低,且全部是中文文献,可能影响研究结论的外推性。因此,建议选用一些关键性的客观指标,严格按照随机对照试验的相关标准,设计高质量、大样本的 RCT 研究进一步论证。

参考文献:

- [1] 邓鑫,梁健,张亚萍,等. 灸法防治艾滋病相关性腹泻探讨 [J]. 广西中医药,2013,36(2):38-39.
- [2] 王永奇. 艾滋病腹泻的中医药研究进展 [J]. 河南中医学院学报,2008,11(6):8-10.
- [3] Monkemuller KE, Call SA, Lazenby AJ, et al. Declining prevalence of opportunistic gastrointestinal disease in the era of combination antiretroviral therapy [J]. Am J Gastroenterol, 2000, 95(2): 457-462.
- [4] 张晓伟,张爱萍,李真,等. 艾滋病相关腹泻 67 例临床分析 [J]. 中国皮肤性病学杂志,2016,36(7):712-713.
- [5] 李静茹,马建萍,马秀兰,等. 艾灸治疗脾胃虚弱型艾滋病腹泻临床观察 [J]. 世界科学技术-中医药现代化,2016,18(2):237-239.
- [6] 郭燕,钱宝延. 艾灸治疗艾滋病腹泻 60 例临床观察 [J]. 河南中医学院学报,2005,20(4):6-7.
- [7] 王金定,黄国恩,翟靖崎,等. 艾条灸治疗艾滋病腹泻症 50 例 [J]. 河南中医学院学报,2006,21(1):14.
- [8] 周立华,唐英,杨国红,等. 中医药治疗艾滋病相关性腹泻临床研究 [J]. 中国中医药信息杂志,2007,14(9):10-12.
- [9] 杨玲,梅希玲,郭淑梅. 藿朴夏苓汤联合水针穴位注射治疗艾滋病相关性腹泻 41 例 [J]. 中医研究,2013,26(5):41-44.
- [10] 王玉玲,王玉光,李坪,等. 311 例艾滋病相关慢性腹泻的临床研究 [J]. 中华实验和临床感染病杂志(电子版),2012,6(3):191-194.
- [11] 苏美奎. 中医药治疗艾滋病腹泻的研究概况 [J]. 中国中西医结合皮肤性病学杂志,2011,10(4):262-263.
- [12] 罗永芬. 腧穴学 [M]. 上海:上海科学技术出版社,2000:134.
- [13] 张晓伟,郭会军,杜磊,等. 艾滋病相关腹泻及其中医药治疗 [J]. 中国中医基础医学杂志,2013,19(12):1435-1436.
- [14] 张昊. 艾滋病相关性腹泻的中医证候研究 [D]. 郑州:河南中医学院,2014.
- [15] 赵少英,许前磊,许向前,等. 论艾滋病腹泻 [J]. 中华中医药杂志,2016,31(4):1165-1167.
- [16] 桑海艳,谢世平,武兴伟. 艾滋病腹泻病例回顾的因子分析 [J]. 光明中医,2011,26(3):457-459.

收稿日期:2017-07-10

作者简介:侯明杰(1983-),男,河南许昌人,硕士研究生,主治医师,研究方向:中西医结合防治艾滋病。

编辑:蒋士卿